

การจัดการความรู้ภาควิชา การพยาบาลสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา เรื่อง "Virus Alert EBOLA"

คณะกรรมการพัฒนาอาจารย์และการจัดการความรู้ ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Virus Alert EBOLA" โดยมี อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์ อาจารย์ประจำของภาควิชาฯ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 12.30-13.30 น. ห้อง 801/1 ชั้น 8 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) ประกอบด้วย 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ไอวอรีโคสต์ สายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อี สายพันธุ์เรสตัน (Reston) และสายพันธุ์ Bundibugyo โดยสายพันธุ์ซูดาน สายพันธุ์ซาร์อี และสายพันธุ์ Bundibugyo ทำให้เกิด การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาและ ทำให้มีอัตราป่วยตายประมาณร้อยละ 60-90

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ติดต่อได้อย่างไร

การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสตรงกับ เลือดที่ติดเชื้อสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ อ้วก หรือน้ำอสุจิ นอกจากนี้ การติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ก็พบได้บ่อยผ่านทางเข็มและหลอดฉีดยา ที่ปนเปื้อนเชื้อ และยังพบการแพร่กระจายเชื้ออีโบลา ในพิธีศพได้บ่อย เนื่องจากผู้มาร่วมพิธีศพอาจมีการสัมผัส โดยตรงกับร่างกายของผู้เสียชีวิต

สำหรับการติดต่อของเชื้อไวรัสอีโบลาสู่คนเกิดจาก การสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือเครื่องในของสัตว์ป่าที่ติดเชื้อ หรือเกิดขณะจัดการหรือชำแหละสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ตาย เช่น ลิง ค่างคาว

โดยยังไม่พบรายงานจากการติดเชื้อผ่านทาง ละอองฝอยที่ลอยในอากาศ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา มีอาการอย่างไร

โรคอีโบลาเป็นโรคเฉียบพลันรุนแรงจากเชื้อไวรัส โดยมากมักจะแสดงออกเป็นไข้เฉียบพลัน อ่อนเพลียมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะและเจ็บคอ ตามด้วยอาการ อาเจียน ท้องเสีย ผื่นผื่นหนัง ไตและตับทำงานบกพร่อง และในบางรายจะพบการตกเลือดทั้งภายในและภายนอก และเสียชีวิต

ผู้ป่วยจะยังอยู่ในระยะติดต่อ คือ ยังสามารถ แพร่เชื้อได้ทราบเท่าที่เลือดและสิ่งคัดหลั่งของตนยังมี เชื้อไวรัส ระยะฟักตัวของโรค ซึ่งหมายถึงระยะเวลานับจาก การเริ่มติดเชื้อไวรัสจนถึงเมื่อเริ่มแสดงอาการ ได้แก่ 2 ถึง 21 วัน

วัคซีนและการรักษา

ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคอีโบลา และยารักษา จำเพาะ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการดูแล รักษาแบบประคับประคองอย่างเข้มงวด ผู้ป่วยมักจะมี อาการขาดน้ำบ่อยๆ จึงจำเป็นต้องได้สารละลายเกลือแร่ เพื่อแก้ไขอาการขาดน้ำโดยอาจให้ทางปาก หรือทาง เส้นเลือด

อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์ ผู้ถอดบทเรียน

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. รศ. ศิริวรรณ สันทัด
2. รศ. ยุวดี วัฒนานนท์
3. ผศ. ทศนียวรรณ พุกษาเมธานันท์
4. ผศ. นิตยา สิ้นสุกใส
5. ผศ. กันยรักษ์ เงยเจริญ
6. ผศ. วาสนา จิติมา
7. ผศ. จรรยา เจริญสุข
8. ผศ. ปิยะนันท์ ลิ้มเรืองรอง
9. อ.ศุภาวดี วายุเหือด
10. อ.ฤดี ปุ๋งบางกะดี
11. อ.รุ่งทิพย์ กาศักดิ์
12. อ.พุทธิราภรณ์ หังสวณัส
13. อ.กุลธิดา หัตถกิจพานิชกุล
14. อ.จิตต์ระพี บุรณศักดิ์
15. อ.อรรวรรณ พินิจเลิศสกุล
16. อ.จิรันดา อ่อนเจริญ
17. อ.รุ่งนภา รัชชอบ
18. อ.นรินทร์ทิพย์ อนันตกุลนธิ